

ANATOMÍA DE UN DOSSIER REGULATORIO

Medicamento nuevo no incluido en Normas Farmacológicas

Alcance: síntesis química, medicamentos biológicos/biotecnológicos y vacunas. Perfil de usuario: equipos mixtos de tecnología, ciencia, salud y regulación.

MATERIAL DE TRABAJO NO OFICIAL | SIN LOGOS | CORTE NORMATIVO: 19 DE AGOSTO DE 2026

La idea central

Un dossier no es un archivo: es un sistema estructurado de evidencia. Reúne documentos, datos, versiones, estudios, certificados, tablas, referencias cruzadas y decisiones que deben ser coherentes entre sí.

Qué intenta demostrar

Que el medicamento puede fabricarse de forma consistente, tiene calidad controlada, ofrece un beneficio clínico sustentado y presenta riesgos conocidos y gestionables.

Qué debe poder hacer un evaluador

Navegar, verificar, comparar, reconstruir la evidencia, identificar incertidumbres y emitir un juicio regulatorio sustentado.

Por qué es difícil

La información está distribuida, puede estar en varios idiomas y formatos, contiene múltiples versiones y exige conocimientos especializados.

Qué busca el hackathon

Asistencia para comprender y gestionar el expediente con mayor rapidez, sin delegar la decisión regulatoria a la IA.

Contexto operativo

Al corte del 14 de julio de 2026, la presentación institucional reportó 26.049 trámites pendientes al inicio del plan, 36.167 nuevos radicados y 50.207 evacuados. La coexistencia de rezago y flujo nuevo explica la necesidad de herramientas seguras de comprensión, priorización y trazabilidad.

Los cinco módulos CTD y las extensiones del formato biológico

CTD = Common Technical Document. Módulo 1 es específico del país; Módulos 2 a 5 siguen una estructura común internacional.

Módulo	Qué contiene	Pregunta del evaluador	Valor para IA
M1	Información administrativa, legal y del producto: solicitante, roles, BPM, certificados, marca, protección de datos, ficha del producto, etiquetado.	¿La solicitud es válida, completa, consistente y jurídicamente soportada?	Clasificar documentos; extraer metadatos; verificar vigencias, firmas, roles, folios y versiones.
M2	Resúmenes y visiones generales de calidad, no clínica y clínica; síntesis del balance beneficio-riesgo.	¿El relato global representa fielmente la evidencia detallada?	Generar mapas de afirmación-evidencia; comparar resúmenes contra M3-M5; señalar omisiones.
M3	Calidad: principio activo, producto terminado, fabricación, controles, métodos, validaciones, impurezas, envase-cierre, estabilidad y transporte.	¿El producto puede fabricarse y controlarse de manera reproducible?	Navegar procesos; enlazar especificaciones y métodos; detectar contradicciones de lotes, estabilidad o fabricantes.
M4	Estudios no clínicos: farmacología, farmacocinética y toxicología.	¿La evidencia preclínica respalda la exposición humana y caracteriza riesgos?	Indexar estudios; extraer especie, dosis, hallazgos, NOAEL y relevancia clínica; comparar resúmenes.
M5	Estudios clínicos: farmacología clínica, eficacia, seguridad, inmunogenicidad, estadística y estudio pivotal.	¿La población, comparador, desenlaces y resultados sustentan la indicación solicitada?	Identificar estudios pivotaes; extraer PICO; trazar resultados; comparar indicación, población y etiquetado.

Extensiones visibles en el ACOM-FOR114 para biológicos

El formato adjunto presenta además M6 información poscomercialización, M7 plan de gestión de riesgos y M8 etiquetado/inserto/información para el prescriptor. Para el hackathon se tratarán como extensiones colombianas del expediente, no como nuevos módulos ICH.

Regla de navegación

Toda afirmación importante debe poder regresar a su fuente: módulo > sección > documento > versión > página o folio > fragmento de evidencia.

El peso no es solo número de páginas

Para este material, “peso” se expresa en dos planos: volumen documental y carga cognitiva para el evaluador.

Componente	Síntesis química	Biológico/biotecnológico	Vacuna
Identidad y origen	Estructura, propiedades físicoquímicas, ruta sintética.	Fuente biológica, línea celular, bancos, caracterización molecular y biológica.	Cepa/semilla, antígeno, plataforma, proceso de atenuación, inactivación o conjugación.
Calidad y proceso	Impurezas, controles de proceso, métodos, validación y estabilidad.	Variabilidad inherente, potencia, pureza, agregados, agentes adventicios y consistencia de lotes.	Potencia, identidad, esterilidad, adyuvante, preservante, diluyente, liberación de lotes y cadena de frío.
Seguridad	Toxicología y perfil clínico de clase/molécula.	Inmunogenicidad, hipersensibilidad y riesgos del proceso/producto.	Reactogenicidad, eventos adversos posteriores a inmunización y seguridad poblacional.
Eficacia	Estudios controlados y relación dosis-respuesta.	Eficacia, PK/PD e inmunogenicidad clínica; comparabilidad cuando aplique.	Respuesta inmune, eficacia clínica o correlatos de protección según producto.

Módulo	Volumen típico relativo	Carga cognitiva	Referencia operativa 2026
M1	Bajo a medio	Media	Metadatos, requisitos legales y trazabilidad regional.
M2	Bajo	Muy alta	Debe sintetizar sin distorsionar M3-M5.
M3	Muy alto	Muy alta	Circular CTD: recomendación de hasta 2.000 folios para síntesis y 6.000 para biológicos.
M4	Alto	Alta	Circular CTD: referencia de hasta 8.000 folios; verificar instructivo operativo.
M5	Muy alto	Muy alta	Circular CTD: referencia de hasta 8.000 folios; verificar instructivo operativo.
M6-M8	Medio	Alta	Poscomercialización, PGR y textos de uso seguro en el formato biológico adjunto.

Punto de control

La Circular 1000-0017-2026 indica que estas extensiones son recomendaciones de presentación, no límites formales, y anunció un instructivo técnico-operativo dentro del mes siguiente. Verificar la versión vigente antes del evento.

Útil, verificable y bajo control humano

La herramienta puede acelerar comprensión y tareas repetitivas; no puede sustituir el juicio ni la competencia de la autoridad.

Bajo riesgo: automatizar

Inventario, clasificación, OCR, deduplicación, nomenclatura, extracción de metadatos, control de versiones, tablas de contenido y navegación.

Riesgo medio: asistir

Resumen con citas, extracción PICO, matrices de evidencia, comparación entre módulos, detección de vacíos y borrador de preguntas para revisión humana.

Alto riesgo: no autonomizar

Interpretación final de beneficio-riesgo, causalidad, suficiencia probatoria, aceptación de una indicación y decisión de otorgar, negar o condicionar.

Salida mínima obligatoria

Respuesta; evidencia; ubicación exacta; versión; nivel de confianza; contradicciones; información faltante; limitaciones y siguiente acción sugerida.

Flujo de referencia para el reto

Radicación única > validación de integridad > clasificación y asignación > evaluaciones farmacológica, farmacéutica/calidad y legal > revisión por Sala cuando aplique > requerimiento consolidado > respuesta y reevaluación > decisión > registro y gestión poscomercialización.

Control no negociable	Qué debe demostrar el prototipo
Trazabilidad	Cada conclusión enlaza a la evidencia primaria y permite volver al documento exacto.
Confidencialidad	No carga datos a servicios externos no autorizados, no reutiliza ni entrena con el expediente.
Seguridad	Control de acceso, cifrado, registro de actividad, retención limitada y defensa frente a instrucciones maliciosas dentro de documentos.
Incertidumbre	Distingue dato extraído, inferencia y recomendación; no inventa; se abstiene cuando la evidencia es insuficiente.
Supervisión humana	El evaluador revisa, corrige y conserva la responsabilidad de la decisión.

Recordatorio

Un modelo de lenguaje no "conoce" el dossier porque haya leído sus páginas. La calidad regulatoria depende de estructura, contexto, evidencia verificable, reglas aplicables y revisión humana competente.